

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	神經系統疾病手術前後 Neurosurgery Perioperative				
編號	A31000-Q03-W-A09	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 08 月 20 日
版本/總頁數	第 3.5 版/8 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解神經系統疾病手術前後的症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

隨著科技的進步，許多醫療器材與技術亦隨之改變，亦可使得腦組織在手術過程中的損傷減至最低，神經系統之手術是否成功，除了醫師技術外，尚需其他醫療小組成員之合作，才能使病人在手術前後得到適當的照護。

（二）症狀

依手術之部位不同，神經外科手術可分為三大類：

1. 腦及其有關構造之腦部手術。
2. 脊髓與其有關構造之手術。
3. 周圍神經手術。

（三）常見檢查

手術前之診斷性檢查包括：

1. 電腦斷層攝影：用以確定病灶位置並顯示出病灶周圍腫脹之程度、腦室的大小，以及有無移位。

主題名稱	神經系統疾病手術前後	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/8

2.核磁共振顯像：其功能與電腦斷層相似，但可提供有關病灶另一角度之檢查結果。

3.腦血管攝影：可以了解病灶處血流供應之情形、血管之分布及有無病灶。

（四）常見治療

1. 手術前處置

(1)服用抗痙攣劑（如 Phenytoin），以減少手術後產生抽搐發作。

(2)類固醇之使用，可使腦水腫獲得緩解。

(3)高滲透性藥物及利尿劑，可降低顱內壓。

2. 手術後處置

(1)放置動脈導管與中央靜脈導管，監測血壓與中心靜脈壓。

(2)提供氧氣治療，降低腦組織缺氧之情形。

(3)高滲透性利尿劑給予，緩解顱內壓升高，並同時限制病人水分的攝入以改善腦水腫現象。

(4)腦部術後多會插入腦室導管以測量顱內壓，並引流腦脊髓液，以控制顱內壓，當顱內壓回復至正常範圍後，即可將導管拔除。

（五）護理問題

1. 焦慮感受／術後相關知識不足及不確定感有關。

2. 顱內壓力調適困難／腦水腫有關。

3. 發燒／下視丘損傷、脫水及感染有關。

4. 體液容積不足／新陳代謝及激素功能失調有關。

5. 知覺感受變異：視覺、幻覺／知覺剝奪或負荷過度與住加護病房有關。

6. 易感染／手術中腦組織之暴露、移動、傷口血腫有關。

7. 無法有效呼吸／制動、換氣不足、肺部吸入異物有關。

8. 身體心像不一致／身體殘障、外觀改變有關。

（六）護理措施

1. 焦慮感受／術後相關知識不足及不確定感有關

主題名稱	神經系統疾病手術前後	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/8

- (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2) 請醫師解釋手術過程協助病人確認可能的壓力來源。
- (3) 向病人解釋開刀前、後的準備工作及注意事項。
- (4) 讓病人瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，減少焦慮。
- (5) 常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (6) 恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。

2. 顱內壓力調適困難／腦水腫有關

- (1) 監測記錄生命徵象。
- (2) 急性期每 1-2 小時監測尿量及比重並記錄。
- (3) 監測每天的輸出入量並記錄。
- (4) 注意能活動病人的安全，防意外發生，如：姿勢性低血壓引起昏眩而跌倒。
- (5) 隨時注意因血清電解質不平衡引起的症狀及徵象例如：意識改變、心電圖變化。

3. 發燒／下視丘損傷、脫水及感染有關

- (1) 監測體溫及生命徵象的變化。
- (2) 評估皮膚的溫度及顏色。
- (3) 監測其實驗室檢驗值，如血液、尿液、細菌培養等。
- (4) 教導調整空調及被蓋，以維持一個較清涼且舒適的環境。
- (5) 監測病人的輸出入量，若尿量每小時每公斤體重少 0.5ml 時應通知醫師。
- (6) 於心腎功能許可下，建議給予 2500-3000c.c./day，以免脫水。
- (7) 衛教家屬及病人，有關可能引起體溫過高的個人及環境因素及特定的預防方法。
- (8) 依醫囑給予靜脈點滴治療。
- (9) 依醫囑給予解熱劑。

4. 體液容積不足／新陳代謝及激素功能失調有關

- (1) 評估皮膚飽滿度。

主題名稱	神經系統疾病手術前後	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/8

(2)觀察是否有脫水的現象（唇裂、口腔黏膜乾燥）。

(3)監測生命徵象。

(4)監測輸入量及排出量及尿比重。

(5)維持靜脈輸入治療管路通暢，必要時依醫囑隨時補充液體。

(6)監測與體液容積缺失有關的各項檢驗結果，注意電解值流失與補充。

(7)補充足夠的水份及維生素，預防脫水。

(8)病房保持陰涼安靜，正常之濕度，以減少水份之喪失。

(9)避免皮膚暴露在乾燥環境。

5. 知覺感受變異：視覺、幻覺／知覺剝奪或負荷過度有關住加護病房

(1)鼓勵病人說出心中的感覺、害怕或焦慮的原因。

(2)澄清病人對環境刺激的錯誤認知或解釋。

(3)盡可能將儀器警告或運作聲音調至適當音量，減少不必要刺激。

(4)執行護理前應向病人解釋，並告知日期、時間給予定向感。

(5)集中護理給予充足的睡眠。

(6)盡可能在病房提供時鐘、日曆及熟悉的物品穩定其定向感。

(7)鼓勵家屬會客時可適當給予病人回憶以往事物，增加病人思考及知覺刺激。

(8)隨時評估病人知覺及感覺變化，適時調整護理措施。

6. 易感染／手術中腦組織之暴露、移動、傷口血腫有關

(1) 監測生命徵象。

(2) 監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。

(3) 記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。

(4) 觀察傷口敷料外觀。

(5) 治療前後洗手。

(6) 無菌技術收集標本培養以監測感染存在。

(7) 依醫囑正確使用冰或熱敷。

(8) 依醫囑按時給予抗生素。

主題名稱	神經系統疾病手術前後	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/8

(9) 依醫囑以無菌技術 CD。

(10) 教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。

(11) 教導感染的危險因子及預防感染的重要性方法。

7. 無法有效呼吸／制動、換氣不足、肺部吸入異物有關

(1) 評估和記錄病人呼吸狀況。

(2) 評估和記錄病人呼吸型態（速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噁嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色）。

(3) 維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。

(4) 教導病人避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。

(5) 依醫囑給予藥物和評估效果（例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等）。

(6) 監測病人對以上治療措施的反應。

(7) 評估動脈血液氣體分析值、肺功能和病人一般臨床狀況改善情況。

8. 身體心像不一致／身體殘障、外觀改變有關

(1) 以主動傾聽、開放式問題，來促進病人表達感受。

(2) 以不批判態度接受病人用憤怒來表達自己的挫折或感受。

(3) 若病人陳述的感受消極、負向且不正確，應適時給予澄清或修正。

(4) 給予病人足夠的時間，做開始接觸患肢的心理準備。

(5) 多與病人接觸，建立良好治療性人際關係，以取得病人信任。

(6) 當病人開始接受改變，應給予鼓勵。

(7) 鼓勵病人習慣別人的眼光，正向的將別人的眼光視為關懷。

(8) 病人若有虔誠的宗教信仰，鼓勵可適當的應用，避免負向情緒的發展。

（七）衛教指導

1. 衛教家屬或病人對於病人所服用之藥物，如抗痙攣劑、止痛劑、軟便劑等，服用方法、時間、劑量、作用與副作用均應瞭解。

2. 衛教個人清潔方面如洗澡，可採淋浴或盆浴，且在傷口拆線前均應保持傷口處乾燥。

主題名稱	神經系統疾病手術前後	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/8

3. 家屬應了解病人在恢復期中，可以做些什麼活動，哪些活動應受到限制。
4. 接受顱骨切開術之病人，因其對大的聲音特別敏感，因此應保持病人周圍環境安靜舒適。
5. 在復健期之病人，若無其他因素影響，於飲食方面並無任何限制。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 唐景俠、黃秀雲、吳孟凌、宋寧娟、盤松青、李德芬、宋琇鈺、蔡玉梅、張淑娟、翁黃玲、胡名宏、張惠甄、盧星華、周心如、林琪馨、白玉珠、李芸玫、周學智、....、蘇淑芬(2021)・急重症護理學・台北市：華杏。
- (二) 張美玉、劉慧玲(2020)・實用重症護理學・台中：五南。
- (三) 馮容芬(2020)・神經系統疾病與護理・新編內外科護理學下冊（第八版，1-196頁）・台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	神經系統疾病手術前後	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容與錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	新增參考文獻出處於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。 第三項第一、二目修訂參考資料。 第六項第二目新增；第三、四目刪除	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

